

# Protocolo de retorno a actividad, trabajo y deporte

Protocolo | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

## 1. Objetivo y resultado esperado

Definir uso seguro, consentimiento y registro de la intervención especializada de la oferta real.

## 2. Alcance y condiciones de uso

Plan funcional progresivo individual; no sustituye certificación médica de aptitud laboral ni alta de otro profesional.

MÓDULO CONDICIONAL: documentar oferta, modalidad, competencia y recursos antes de activar. Si no se oferta, justificar no aplicabilidad sin eliminar los controles generales.

## 3. Responsabilidades por rol

| Rol                        | Responsabilidad                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta responsable | Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.   |
| Ejecutor según proceso     | Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia. |
| Verificador o titular      | Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.      |

## 4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

## Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

### **1. Verificar identidad, plan, objetivo y decisión antes de contacto**

Verificar identidad, plan, objetivo y decisión antes de contacto. Explicar actividad, límites, alternativas y posibilidad de detener; no aplicar por rutina o por disponibilidad de equipo.

### **2. Valorar elegibilidad y riesgo: Definir demandas, restricción médica si existe, síntomas y**

Valorar elegibilidad y riesgo: Definir demandas, restricción médica si existe, síntomas y capacidad actual. La finalización de sesiones no demuestra aptitud para toda carga o deporte. Registrar hallazgos, decisión y razones de remitir o aplazar.

### **3. Preparar ambiente y ayudas, privacidad, insumos y equipo compatibles, manual de fabricante**

Preparar ambiente y ayudas, privacidad, insumos y equipo compatibles, manual de fabricante cuando aplica y ruta de respuesta. Sin recurso crítico no iniciar.

### **4. Aplicar con este criterio: Establecer tareas y criterios funcionales verificables, exposic**

Aplicar con este criterio: Establecer tareas y criterios funcionales verificables, exposición progresiva, descansos y vigilancia. Documentar pruebas seguras y límites; coordinar cuando el riesgo excede fisioterapia. Mantener intervención dentro de competencia y condiciones comprobadas.

### **5. Vigilar síntomas y respuesta, detener ante dolor inesperado, lesión de piel, mareo importa**

Vigilar síntomas y respuesta, detener ante dolor inesperado, lesión de piel, mareo importante, deterioro o solicitud del paciente. Controlar riesgo y atender antes de llenar reporte.

### **6. Registrar respuesta, educación, cuidados y conducta**

Registrar respuesta, educación, cuidados y conducta. Limpiar o disponer insumos según contacto y fabricante, planear seguimiento y revisar eficacia antes de repetir.

## Control, frecuencia y corrección

### 5. Verificación de la ejecución

Elegibilidad individual antes de cada sesión.

Recursos y manuales auténticos.

Vigilancia y decisión de detener.

Registro clínico y eficacia, sin garantía de resultados.

| Momento       | Comprobación y conducta                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes         | Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.  |
| Durante       | Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso. |
| Después       | Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.   |
| Ante hallazgo | Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.  |

### 6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

### 7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

### 8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

## Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Paciente fecha y sesión     |  |
| Motivo y objetivo           |  |
| Elegibilidad y alarmas      |  |
| Consentimiento específico   |  |
| Técnica región y posición   |  |
| Recurso o equipo            |  |
| Parámetros o actividad real |  |
| Respuesta y vigilancia      |  |
| Cuidados y continuidad      |  |
| Autor y autenticación       |  |

### Fuentes y límites

#### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

#### Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

#### Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576